Costo de oportunidad

Nombre: _____

Fecha: _____

Las tres partes usan ejemplos ilustrativos del Estado de Luvina. Escriba sus respuestas y compare con su facilitador.

Parte A. Jeringas prellenadas o viales

El servicio de medicina interna del Hospital General de Luvina aplica 120 dosis por semana de un mismo medicamento. El medicamento existe en vial y en jeringa prellenada. La dosis y el efecto son idénticos.

Preparar y aplicar una dosis desde vial toma 15 minutos de enfermería. Con jeringa prellenada toma 5 minutos. La jeringa prellenada cuesta MXN 80 más por dosis.

1. ¿Cuántas horas de enfermería por semana usa el servicio con viales?

Respuesta: _____ horas

2. ¿Y con jeringas prellenadas?

Respuesta: _____ horas

3. ¿Cuántas horas de enfermería por semana libera la jeringa prellenada?

Respuesta: _____ horas

4. ¿Cuánto gasta de más el servicio por semana si usa jeringas prellenadas?

Respuesta: _____ MXN

5. Si el servicio elige viales, ¿a qué renuncia?

- ☐ A nada, porque el vial es más barato.
- ☐ A 20 horas de enfermería por semana que podrían dedicarse a otras tareas.
- ☐ A MXN 9,600 por semana.

6. Si el servicio elige jeringas prellenadas, ¿a qué renuncia?

- ☐ A MXN 9,600 por semana que podrían pagar otro insumo o servicio.
- ☐ A 20 horas de enfermería por semana.
- ☐ A nada, porque libera tiempo de enfermería.

Parte B. Un presupuesto fijo para tamizaje

El ISES tiene MXN 3,000,000 para un programa de tamizaje. Hay dos pruebas disponibles para la misma enfermedad: la prueba X cuesta MXN 500 por persona y la prueba Y cuesta MXN 750 por persona.

7. ¿A cuántas personas tamiza el ISES con la prueba X?
Respuesta: _____ personas

8. ¿Y con la prueba Y?
Respuesta: _____ personas

9. Si el ISES elige la prueba Y, ¿a cuántas personas tamizadas renuncia?
Respuesta: _____ personas

10. ¿Qué dato falta para saber si la renuncia vale la pena?

- ☐ El precio de cada prueba.
- ☐ Cuántos casos detecta cada prueba en la población tamizada.
- ☐ El número de clínicas del ISES.

Parte C. Verdadero o falso

11. Con más presupuesto, la escasez en salud desaparece.
☐ Verdadero ☐ Falso

12. Si una intervención es eficaz, el sistema público debe financiarla.
☐ Verdadero ☐ Falso

13. Cuando nadie hace explícito el costo de oportunidad, este deja de existir.
☐ Verdadero ☐ Falso

14. Lo que se deja de financiar son pacientes, tratamientos o programas concretos.
☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U01.